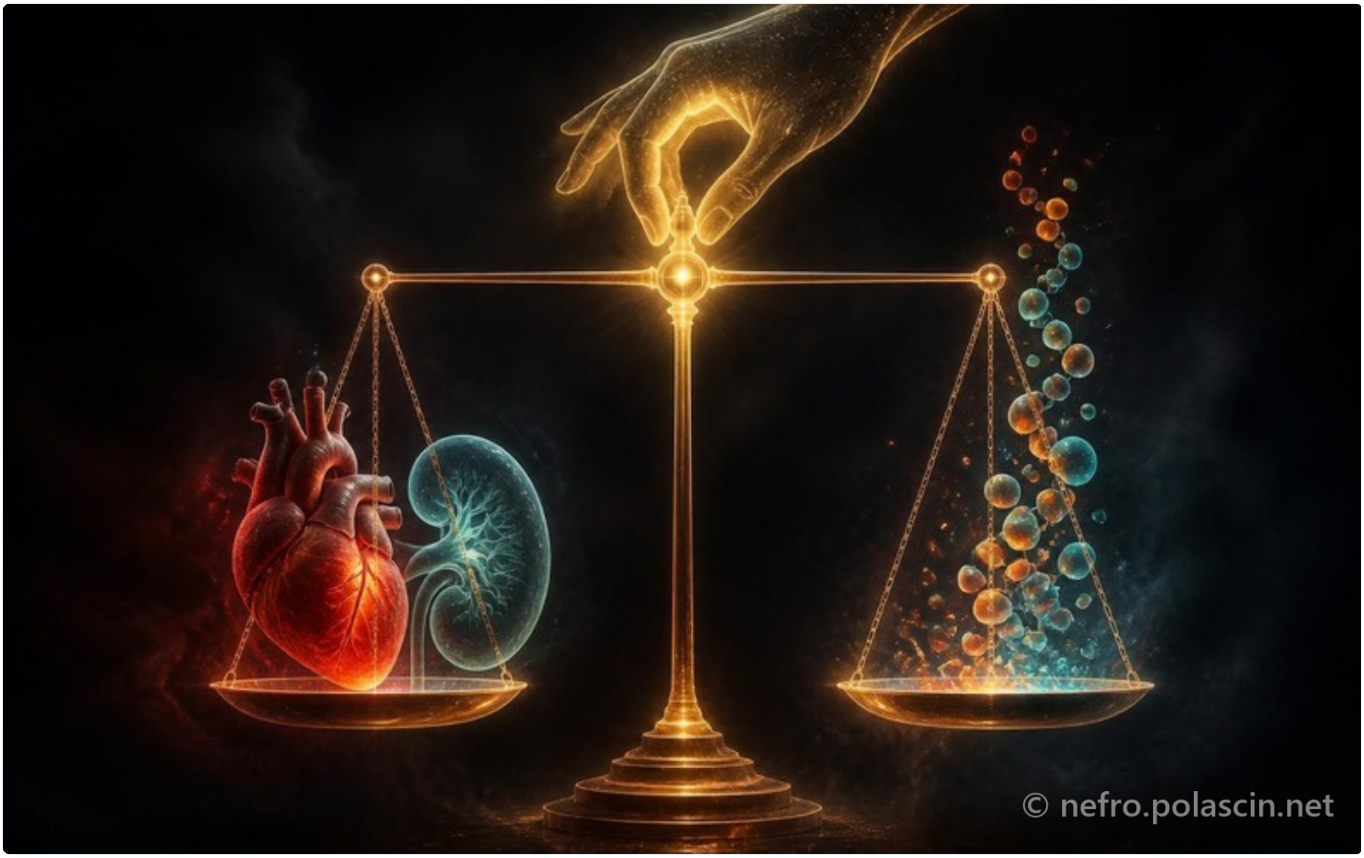
Optimalizácia RAASi/MRA terapie u pacientov so srdcovým zlyhávaním, CKD a hyperkaliémiou (praktický prístup)

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 02.06.2026



Poloschematická vizualizácia. Vysadiť liečbu je najjednoduchšie riešenie – a spravidla najhoršie pre pacienta.

Úvod

RAASi (ACEi/ARB) a MRA (mineralokortikoidový receptorový antagonista) patria medzi základné liečivá v manažmente pacientov so srdcovým zlyhávaním a srdcovo-obličkovým prepojením. V reálnej praxi však často narážame na bariéru, ktorou je hyperkaliémia. Namiesto automatického znižovania dávok alebo vysadenia liečby sa moderný prístup usiluje udržať pacienta na účinnej schéme RAASi/MRA a hyperkaliémiu riešiť aktívne, systematicky a predvídateľne.

Prečo RAASi/MRA „padá“ kvôli draslíku

Najčastejšie dôvody, prečo sa RAASi/MRA v praxi nepodáva v cieľovej dávke alebo sa prerušuje:

- vysoké východiskové sérové K^+ alebo jeho dynamická variabilita,
- zhoršená funkcia obličiek, dehydratácia alebo interkurentné zhoršenie,
- liekové interakcie zvyšujúce draslík (napr. kombinácie s inými látkami ovplyvňujúcimi renín-angiotenzín-aldosterónovú os),
- nedostatočná preventívna stratégia na normalizáciu K^+ pred titráciou,
- nedostatočné alebo príliš „neskoré“ laboratórne monitorovanie po úprave terapie.

Podstata: hyperkaliémia nie je dôvod na rezignáciu na RAASi/MRA, ale signál na aktívnu optimalizáciu stratégie manažmentu draslíka.

Kľúčový princíp: optimalizuj terapiu a hyperkaliémiu zároveň

Prakticky to znamená paralelne riešiť dve veci:

1. **RAASi/MRA terapia:** začať a titrovať podľa tolerancie a cieľov (prínos pri HF/CKD).
2. **Draslík:** znížiť riziko a liečiť hyperkaliémiu tak, aby bolo možné udržať a prípadne zvyšovať dávky RAASi/MRA.

Tento „dvojkoľajný“ prístup znižuje počet situácií, keď pacient skončí na suboptimálnej dávke len preto, že K^+ sa zvyšuje.

Praktický postup v ambulancii (pracovný rámec)

1) Pred titráciou: zhodnoť riziko hyperkaliémie

Skontroluj:

- aktuálne a trendové hodnoty K^+,
- odhad GFR a dynamiku kreatinínu,
- hydratáciu, diuretický režim a prípadné „skryté“ zhoršenie stavu,
- aktuálne lieky, ktoré môžu draslík zvyšovať,
- ďalšie faktory: metabolická acidóza, diétne excesy draslíka (aspoň orientačne), pridružené ochorenia.

Cieľom je predvídať, a nie až reagovať po tom, čo sa K^+ zvýši.

2) Titruj RAASi/MRA plánovane, s reálnym monitoringom

Po zmene dávky je rozumné nastaviť laboratórnu kontrolu tak, aby zachytila trend draslíka včas. V praxi to typicky znamená kontrolu v prvých dňoch až týždňoch podľa lokálneho protokolu a rizikovosti pacienta.

Keď K^+ začne rásť, titrácia a riešenie draslíka sa nemajú spomaľovať; problémy sa riešia v momente, keď K^+ už dosahuje výraznejšie hodnoty a problém je „v plnom rozsahu“.

3) Keď K^+ rastie: rieš príčiny + uvoľni cestu pre udržanie RAASi/MRA

V praxi sa osvedčuje kombinácia krokov, ktoré majú zmysel aj vtedy, keď ide o chronickú hyperkaliémiu:

- **Liečebné úpravy podporujúce kaliurézu:** optimalizuj diuretiká tam, kde dávajú klinický zmysel (najmä u pacientov so sklonom k retencii tekutín).
- **Prehodnoť príjem draslíka v strave:** nie ako jednorazový zákaz, ale ako praktické obmedzenie zdrojov s vysokým obsahom draslíka a edukáciu, aby pacient vedel, čo reálne riešiť.
- **Metabolická acidóza:** ak je prítomná, jej korekcia môže zlepšiť acidobázickú situáciu a nepriamo ovplyvniť draslík (riešiť v súlade s lokálnou praxou a stavom pacienta).
- **Novšie stratégie pre chronickú kontrolu draslíka:** ak sa bez nich RAASi/MRA nedarí udržať v požadovaných dávkach, medzinárodné odporúčania uvádzajú aj liečivá viažuce draslík ako nástroj, ktorý umožní v RAASi/MRA pokračovať. Týka sa to najmä opakovaného alebo pretrvávajúceho zvyšovania K^+.

Dôležité: cieľ nie je „iba dostať K^+ na číslo“, ale dostať pacienta do stavu, v ktorom môže dlhodobo profitovať z RAASi/MRA.

Ako nastaviť cieľ a úspech

Pri takomto manažmente má zmysel definovať úspech minimálne v troch rovinách:

- pacient má **stabilne prijateľný K^+**,
- RAASi/MRA je **udržaná** (ideálne v čo najvyššej tolerovanej dávke),
- nevznikajú opakované akútne eskalácie (hospitalizácie kvôli hyperkaliémii, urgentné zmeny terapie).

Úspech teda zahŕňa laboratórny výsledok aj trvalý klinický prínos.

Časté chyby, pre ktoré pacienti prichádzajú o RAASi/MRA

1. Reakcia až vo chvíli výrazného vzostupu draslíka.
2. Úplné vysadenie RAASi/MRA bez paralelného plánu, ako draslík zvládnuť.
3. Nezohľadnenie liekových interakcií a „neviditeľnej“ dynamiky renálnej funkcie.
4. Slabá edukácia pacienta o praktických diétnych a režimových opatreniach.
5. Nedostatočné monitorovanie po každej úprave dávky.

Záver

Hyperkaliémia je v kardiorenálnom manažmente častou prekážkou, ale nemá byť dôvodom na trvalé podliečenie pacienta RAASi/MRA terapiou. Cieľom je udržať a optimalizovať RAASi/MRA, súčasne proaktívne riešiť príčiny hyperkaliémie a mať pripravený plán na kontrolu draslíka. Vzdelávacie programy k tejto téme opakovane zdôrazňujú, že udržať liečbu sa často darí práve vďaka včasnej stratifikácii rizika a cielenej intervencii pri hyperkaliémii.

Zdroj: *Global Kidney Academy, mikrolearning kurz „Optimizing RAASi/MRA therapy in patients with heart failure, CKD and hyperkalemia: a microlearning curriculum approach“. Navštíviť zdroj.*

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=optimalizacia-raasi-mra-hyperkaliemia-ckd-hf · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.